

ІННОВАЦІЯ онкологічна клініка 		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 3 607 686 5
ТОВ "Медична клініка "Інновація" тел. (044) 331-21-00, (067) 503-59-22 Ліцензія АЕ 459319 від 27.08.2014 видана МОЗ України www.innovacia.com.ua	ІННОВАЦІЯ онкологічна клініка 	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 0 2 8 / о Затверджена наказом МОЗ України 14.02.2012 р. № 110

Епікриз

Пациєнт Жерліцина Анастасія Станіславівна , 47 років	СК
Телефон № (м):0685975246	Поліс №
ЕМК № 7140773	Координатор
Документ № IX-230502/5819.E1/1	від 08.05.2023 8:59:00
Картка № Стационарна карта №IX-230502/5819 від 03.05.2023	
Відділення Поліклінічне відділення	Лікар Лациннікова Оксана Миколаївна

Пациєнтка Жерліцина А. С. , 1976р.н., знаходилася на лікуванні 03-08.05.2023р. в умовах стаціонару клініки "Інновація".

Діагноз: GIST шлунку з вторинним враженням печінки.

Стан після EUS-FNA біопсії шлунку (21.04.2023), core-біопсії

печінки (25.04.2023), гістологічно - гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST) шлунку, метастаз GIST в печінку (CSD).

Стан після трепан-біопсії печінки (28.08.2022 р. НІР). ПГЗ: лейоміосаркома матки.

Стан після 4-х циклів хіміотерапії за протоколом Гемцитабін+Доцетаксел+Авастин з прогресією в печінці (МРТ ОЧП, ОМТ 14.10.2022, КТ 01.12.2022).

Виявлено мутації Kit, MET (повногеномне секвенування ONCOMINE, 12.2022).

Лікування Пазопанібом 05-12.01.2023р. з розвитком синдрому задньої зворотної енцефалопатії та позитивною динамікою по даним КТ від 09.02.2023р.

Повторна біопсія печінки (23.01.2023р., Оберіг). ПГЗ: метастаз лейоміосаркоми матки.

Стан після 3-х циклів хіміотерапії за протоколом Трабектідин з мінімальною негативною динамікою по даним ПЕТ-КТ (11.04.2023): Відомі маси в печінці та маса ліворуч, що за конфігурацією скоріш походить зі стінки шлунку незначно збільшилися, метаболічно активні. Маса в матці та в/біля правого яєчника з низькою метаболічною активністю, структурно стабільні. Істотна різниця в активності мас печінки/шлунку та матки дозволяє припустити різні неопластичні процеси, зокрема , первинно агресивну з шлунку/GIST. Первинна біопсія від 08.2022р. в процесі перегляду в лабораторії CSD.

Супутний діагноз: Залізодефіцитна анемія. Цукровий діабет 2 тип. Гіповітаміноз Д.

Закритий відламковий перелом дистального метаепіфізу лівої променевої кістки зі зміщенням відламків (11.02.2023р.)

Актуальна госпіталізація: початок лікування Іматинібом, симптоматичне лікування (профілактика tumor lysis syndrome).

13.02.2023р. -імплантована система для внутрішньовенних інфузій Port-A-Cat.

Активних скарг на момент огляду не висказує.

Об'єктивно: загальний стан задовільний. Шкірні покриви і видимі слизові оболонки звичайного забарвлення, чисті, сухі. Дихання везикулярне, вислуховується на всьому протязі, хрипів немає. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. Живіт м'який, безболісний при пальпації, печінка збільшена до рівня пупка, активна перистальтика. Діурез - достатній, стілець- 1 раз /доба, рідкий.

Проведена терапія: дексаметазон, контролок, сольові розчини, еліквіс, глюкофаж, сорбіфер, гепавіста детокс, аденурік, сода, Кальцій+Д3.

Лікування перенісла задовільно.

Результати аналізів додані.

Рекомендовано:

1. При нудоті - Зофетрон по 8 мг (1 таб) всередину 1- 3 рази на день , максимальна добова доза - 32 мг (4 таблетки на добу), також можливий прийом Церукалу по 10-20 мг (1-2 таблетки), до 6 таблеток на день, у 2-3 прийоми.

2. При явищах мукозиту (почервоніння, набряклість, виразка слизової ротової порожнини) - почати обробку ротової порожнини оральними антисептиками (орасепт, гивалекс, стоматидин), при погіршенні

стану - дифлюкан по 150 мг всередину (за узгодженням).

3.Дотримання питного режиму - вживання не менше 2 -2.5л рідини на добу (вода РЕО) (під контролем діурезу та показників артеріального тиску!)

4.При сухості шкіри – використання жирних кремів та косметичних масел, при сухості кон'юнктиви – краплі «Штучні сльози» або «Хіло-Кеа». При сухості слизової носа – спрей «Аква-Марис» або «Х'юмер», «Марімер», масляні розчини хлорофіліпту, масло обліпихи, оливкова олія. Обробляти слизову оболонку носа синтоміциновою маззю 2-3 рази на день 10 днів.

5. Загальний аналіз, біохімічний аналіз крові 1 раз на тиждень.

6.При підвищенні температури тіла вище 380С, розпочати антибактеріальну терапію (за погодженням з лікарем!!!).

7.При запорах - Дуфалак по 20 мл 1 раз на день щодня після сніданку.

8.При проносі почати Імодіум-2 капс. одразу, потім по 1 капс. після кожного епізоду рідкого випорожнення (до 8 капс на добу).

9.При погіршенні самопочуття-тел. чергового лікаря 096 8151618

10. Аденурік по 80 мг щоденно.

11. Еліквіс по 2.5 мг 2 рази на день тривало.

12.Віт д3 по 4 тис Од/день 3 міс суммарно, контроль рівня віт Д3 через 2 тижні.

13.Виконувати рекомендації травматолога.

14.Виконувати рекомендації ендокринолога.

15. Гепавіста -детокс по1 таб мг 2 рази на день.

16. Продовжити прийом Іматинібу по 400 мг щодня.

17. Контрольний огляд 15.05.2023р.

Клінічний діагноз

Основний: Діагноз: GIST шлунку з вторинним враженням печінки.

Лікар _____ /Лаціннікова О.М./